

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2026 г. № 29**

Об утверждении клинического протокола

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХП «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить клинический протокол «Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 115 «Об утверждении клинического протокола».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Ходжаев

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
08.04.2026 № 29

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий»

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему медицинских услуг, медицинских вмешательств при применении вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) в лечении пациентов с бесплодием (шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра – E28.3 Первичная яичниковая недостаточность; E28.8 Другие виды дисфункции яичников; F52.2 Недостаточность генитальной реакции; F52.5 Вагинизм неорганического происхождения; N48.4 Импотенция органического происхождения; N46 Мужское бесплодие; N97 Женское бесплодие: N97.0 Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции; N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения; N97.2 Женское бесплодие маточного происхождения; N97.3 Женское бесплодие цервикального происхождения; N97.4 Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами; N97.8 Другие формы женского бесплодия; N97.9 Женское бесплодие неуточненное; Q51 Врожденные аномалии [пороки развития] развития тела и шейки матки: Q51.0 Агенезия и аплазия матки; Q51.1 Удвоение тела матки с удвоением шейки матки и влагалища; Q51.2 Другие удвоения матки; Q51.3 Двурогая матка; Q51.4 Однорогая матка; Q51.5 Агенезия и аплазия шейки матки; Q51.6 Эмбриональная киста шейки матки; Q51.7 Врожденный свищ между маткой и пищеварительным и мочевым трактами; Q51.8 Другие врожденные аномалии тела и шейки матки; Q51.9 Врожденная аномалия тела и шейки матки неуточненная; Z90.7 Приобретенное отсутствие полового органа (органов)).

2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными для организаций здравоохранения, осуществляющих применение ВРТ в соответствии

со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях».

3. Для целей настоящего клинического протокола используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», Законом Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях», а также следующие термины и их определения:

бластоциста – стадия развития эмбриона, наступающая на 5–7 день после оплодотворения;

вспомогательный хетчинг – микроманипуляция в рамках ВРТ, во время которой блестящую оболочку эмбриона перфорируют химически, механически или с помощью лазера;

интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку (IntraCytoplasmic Sperm Injection, далее – ИКСИ) – процедура, во время которой один сперматозоид вводят в цитоплазму яйцеклетки;

контролируемая овариальная стимуляция (далее – КОС) гормональная терапия в программах ВРТ, направленная на созревание нескольких фолликулов в течение одного цикла для получения оптимального количества зрелых яйцеклеток;

культивирование эмбрионов – ключевой этап экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), заключающийся в выращивании оплодотворенных яйцеклеток (эмбрионов) в специальных лабораторных условиях вне организма женщины;

лютеиновая фаза – вторая половина менструального цикла (после овуляции), длящаяся в среднем 14 дней;

овариальный резерв – индивидуальный запас фолликулов с яйцеклетками в яичниках, определяющий способность женщины к зачатию;

олигоастенотератозооспермия – комплексное нарушение качества спермы, характеризующееся одновременным снижением числа сперматозоидов, их подвижности и аномальным строением (морфологией);

предимплантационное генетическое тестирование (далее – ПГТ) – метод диагностики генетических заболеваний у эмбриона человека до его переноса в полость матки;

пункция фолликулов яичника – медицинская манипуляция с целью получения яйцеклеток (ооцитов) для ЭКО;

ретроградная эякуляция – нарушенный процесс семяизвержения, в ходе которого выброс спермы производится в обратном направлении;

самостоятельный выход женщины из цикла ЭКО – решение пациентки прервать цикл ЭКО по собственному желанию после начала КОС;

стимуляция овуляции – фармакологическая терапия с целью индуцировать развитие фолликулов в яичниках;

трансплантация (перенос) эмбриона – ключевой этап ЭКО, при котором культивируемый в лаборатории эмбрион переносится в полость матки женщины через тонкий катетер под ультразвуковым контролем;

эякуляторная дисфункция – сексуальное расстройство у мужчин, характеризующееся нарушением процесса семяизвержения (ускорение, задержка, отсутствие или ретроградная эякуляция).

4. В настоящем клиническом протоколе приведены базовые схемы фармакотерапии, включающие основные фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов (далее – ЛП).

5. ЛП и медицинские изделия (далее – МИ) назначаются и применяются в соответствии с настоящим клиническим протоколом с учетом всех индивидуальных особенностей пациента (медицинских противопоказаний, аллергологического и фармакологического анамнезов) и клинико-фармакологической характеристики ЛП и МИ.

ЛП представлены по международным непатентованным наименованиям, а при их отсутствии – по химическим наименованиям по систематической или заместительной

номенклатуре, с указанием пути введения; лекарственных форм и дозировок, режима дозирования с указанием разовой (при необходимости суточной, максимальной разовой) дозы.

6. Применение ЛП осуществляется по медицинским показаниям в соответствии с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем). Допускается включение в схему лечения ЛП по медицинским показаниям или в режиме дозирования, не утвержденным инструкцией по медицинскому применению (листами-вкладышами) и общей характеристикой ЛП (off-label), с дополнительным обоснованием и указанием особых условий назначения, способа применения, дозы, длительности и кратности приема.

ГЛАВА 2

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

7. Для лечения бесплодия ЭКО применяется при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний к применению ВРТ и к донорству половых клеток в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 октября 2025 г. № 170 «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий» (далее – постановление № 170).

8. ЭКО включает следующие этапы:

8.1. индивидуальная КОС с применением различных ЛП (агонистов и антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона, рекомбинантных и мочевых гонадотропинов, хорионического гонадотропина, антиэстрогенов).

Основными протоколами КОС являются длинный протокол (с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона (далее – а-ГнРГ)) и короткий протокол (с антагонистом гонадотропин-рилизинг гормона (далее – ант-ГнРГ)). В зависимости от клинической ситуации возможно применение иных схем стимуляции.

В протоколе ЭКО с а-ГнРГ используются следующие ЛП:

трипторелин (раствор для подкожного (далее – п/к) введения 0,1 мг/мл 1 мл) ежедневно со 2-го дня цикла КОС или с лютеиновой фазы менструального цикла женщины, предшествующей стимуляции, с уменьшением дозы либо без уменьшения дозы на фоне стимуляции до дня назначения триггера (средняя доза трипторелина 0,1 мг – 21 ампула);

трипторелин (раствор для п/к введения 0,1 мг/мл 1 мл), лейпрорелин в пролонгированной форме (порошок/раствор) в дозе 3,75 мг, внутримышечно (далее – в/м) или п/к, со 2-го дня цикла КОС или с лютеиновой фазы менструального цикла женщины, предшествующей стимуляции; возможно индивидуальное сочетание пролонгированной формы с ежедневной;

в протоколе ЭКО с ант-ГнРГ используются цетрореликс (лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения 0,25 мг) или ганиреликс (раствор для п/к введения по 0,25 мг) по гибкому или фиксированному протоколу ежедневно до назначения триггера, количество инъекций определяется продолжительностью стимуляции;

для стимуляции яичников с целью роста когорты фолликулов применяются рекомбинантные и мочевые гонадотропины (фолликулостимулирующий гормон (далее – ФСГ), лютеинизирующий гормон (далее – ЛГ) и комбинированные рекомбинантные и мочевые гонадотропины (ФСГ + ЛГ), антиэстрогены, ингибиторы ароматазы;

фоллитропин альфа, лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения 5,5 мкг (75 международных единиц (далее – МЕ)), раствор для п/к введения 22 мкг (300 МЕ) в шприц-ручке 0,5 мл в комплекте с иглами, раствор для п/к введения 33 мкг (450 МЕ) в шприц-ручке 0,75 мл в комплекте с иглами, раствор для п/к введения 66 мкг (900 МЕ) в шприц-ручке 1,5 мл в комплекте с иглами;

фоллитропин бета, раствор для п/к введения (картриджи 300 МЕ и 600 МЕ) для шприц-ручки;

менотропин (гонадотропин менопаузный), лиофилизат для приготовления раствора для в/м и п/к введения 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ;

рекомбинантный комбинированный фоллитропин альфа 150 МЕ + лутропин альфа 75 МЕ;

антиэстрогены: кломифена цитрат (таблетки 50 мг), максимальная суточная доза 150 мг, тамоксифен (таблетки 10 мг, 20 мг), максимальная суточная доза 40 мг;

ингибиторы ароматазы: летрозол (таблетки 2,5 мг), максимальная суточная доза 7,5 мг.

Дозы ЛП зависят от возраста и овариального резерва яичников и подбираются для каждой женщины индивидуально. Максимальная суточная доза гонадотропинов 450 МЕ.

Суммарная доза гонадотропинов для стимуляции составляет 700–4200 МЕ рекомбинантного или мочевого гонадотропина.

В протоколах стимуляции допускается комбинация рекомбинантного и мочевого гонадотропинов.

Подбор и коррекция доз ЛП в протоколе КОС осуществляется с учетом результатов мониторинга индивидуального ответа яичников на КОС.

При отсутствии ответа на стимуляцию овуляции (подтверждается отсутствием роста фолликулов при ультразвуковом исследовании органов малого таза) в течение 7–8 дней (исключение – женщины с гипогонадизмом, которым допустимо продолжить стимуляцию овуляции до 14–15 дней), а также в случае отсутствия ооцитов или эмбрионов женщина исключается из протокола ЭКО;

8.2. введение триггера с целью финального дозревания яйцеклеток:

рекомбинантный хориогонадотропин альфа, раствор для п/к введения 250 мкг / 0,5 мл, в дозе 250 мкг;

гонадотропин хорионический, лиофилизат для приготовления раствора для в/м (и п/к) введения (для инъекций) в дозах от 1500 МЕ до 10 000 МЕ включительно.

Допускается замена триггера на а-ГнРГ или применение двойного триггера;

8.3. мониторинг стимуляции цикла, трансвагинальная пункция под ультразвуковым контролем и хирургическая трансплантация (перенос) эмбрионов осуществляются врачом-акушером-гинекологом (специалистом по ВРТ);

8.4. пункция фолликулов проводится через 34–38 часов после введения триггера.

Пункция фолликулов яичников для получения яйцеклеток осуществляется трансвагинальным доступом под ультразвуковым контролем с анестезиологическим пособием (обезболиванием). При невозможности выполнения трансвагинального доступа яйцеклетки могут быть получены трансабдоминальным или лапароскопическим доступом. Вид анестезиологического пособия определяется врачом-анестезиологом-реаниматологом;

8.5. оплодотворение яйцеклеток специально подготовленными сперматозоидами супруга или сперматозоидами донора половых клеток (далее, если не указано иное, – донор) (метод специальной обработки эякулята зависит от его параметров и определяется специалистом по ВРТ) осуществляется с применением следующих методов:

оплодотворение яйцеклеток сперматозоидами в культуральной среде (in vitro fertilization);

ИКСИ;

8.6. культивирование эмбрионов от 48 до 168 часов;

8.7. перенос эмбрионов в полость матки пациентки. Эмбрионы переносятся от стадии дробления до стадии бластоцисты. Выбор эмбриона(ов) осуществляется врачом клинической лабораторной диагностики или биологом совместно с врачом-акушером-гинекологом. При отсутствии эмбрионов (подтверждается протоколом культивирования эмбрионов) женщина исключается из протокола ЭКО.

9. Программа ЭКО считается завершенной после переноса эмбриона(ов) в полость матки (подтверждается протоколом операции и протоколом культивирования эмбрионов),

исключения из протокола по медицинским показаниям (отсутствие яйцеклеток, получение яйцеклеток низкого качества, отсутствие эмбрионов, получение эмбрионов низкого качества, не подлежащих переносу и не рекомендованных к переносу после ПГТ), криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов без переноса в полость матки в цикле ЭКО, самостоятельного выхода женщины из цикла ЭКО.

10. Программа ЭКО может дополняться следующими этапами:

криоконсервация половых клеток (яйцеклеток, сперматозоидов);

криоконсервация эмбрионов;

перенос в матку размороженных после криоконсервации эмбрионов;

ПГТ эмбрионов.

Криоконсервация половых клеток (яйцеклеток, сперматозоидов) осуществляется с целью сохранения репродуктивного потенциала пациентов при условии соблюдения требований законодательства о ВРТ.

11. Перед переносом эмбрионов в полость матки в отдельных случаях (неудачные попытки ЭКО с переносом эмбрионов хорошего качества в анамнезе; изменение морфологии блестящей оболочки эмбриона; использование криоконсервированных эмбрионов) проводится вспомогательный хетчинг с целью облегчения имплантации бластоцисты в слизистую матки.

12. ПГТ проводится с целью медицинской профилактики врожденных и наследственных заболеваний, не является альтернативой инвазивной пренатальной диагностике и не исключает ее проведения для внутриутробного уточнения диагноза плода.

13. Поддержка лютеиновой фазы после переноса эмбрионов стимулированного цикла ЭКО проводится преимущественно ЛП группы прогестерона и их аналогов, режим дозирования определяется лечащим врачом-акушером-гинекологом для каждой женщины индивидуально:

прогестерон, раствор для внутримышечного введения (масляный), 1 мл – 10 мг, 1 мл – 25 мг, максимальная суточная доза 50 мг;

прогестерон, раствор для подкожного введения, 1 флакон – 25 мг, максимальная суточная доза 25 мг;

прогестерон, вагинальный гель, 90 мг, максимальная суточная доза 180 мг;

прогестерон микронизированный, капсулы 100 мг, 200 мг, максимальная суточная доза 800 мг;

дидрогестерон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, максимальная суточная доза 40 мг.

Женщинам с недостаточностью яичников или нерегулярными менструальными циклами, «тонким» эндометрием, а также в программах донации яйцеклеток (ооцитов), переноса размороженных эмбрионов применяется циклическая гормонотерапия с назначением эстрогенов (в таблетированной и (или) трансдермальной форме) в фолликулиновую фазу и гестагенов с продолжением сочетанной гормональной поддержки в посттрансферном периоде.

Эстрогены назначаются в следующих формах и дозах:

эстрадиол валерат, драже 2 мг, перорально, максимальная суточная доза 8 мг;

эстрадиол, гель для наружного применения, при одном нажатии на помпу-дозатор высвобождается 1,25 г геля (что соответствует 0,75 мг эстрадиола), максимальная суточная доза 7,5 г геля (4,5 мг эстрадиола);

эстрадиол, гель трансдермальный 0,1 %, 0,5 мг/пакет, максимальная суточная доза 4 мг;

эстрадиол 1,53 мг (в виде эстрадиола гемигидрата 1,58 мг) в каждой дозе, максимальная суточная доза составляет 3 нанесения (4,59 мг/сутки) на кожу.

14. Диагностика беременности проводится путем исследования количественного уровня хорионического гонадотропина в крови через 10–14 дней со дня переноса эмбрионов и ультразвукового исследования органов малого таза через 21–30 дней со дня переноса эмбрионов.

15. ЭКО проводится в том числе в естественном менструальном цикле без применения КОС (ЭКО в естественном цикле).

ЭКО в естественном цикле применяется по медицинским показаниям, включая низкий овариальный резерв, медицинские противопоказания к гормональной стимуляции, отказ пациентки от КОС, а также в иных клинических ситуациях по решению лечащего врача-акушера-гинеколога.

В естественном цикле проводятся мониторинг роста доминантного фолликула, введение триггера овуляции (при необходимости), пункция фолликула, оплодотворение яйцеклетки, культивирование эмбриона и перенос эмбриона в полость матки либо его криоконсервация.

ГЛАВА 3

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКО С ИНЪЕКЦИЕЙ СПЕРМАТОЗОИДА В ЦИТОПЛАЗМУ ООЦИТА

16. Программа ЭКО с ИКСИ применяется после принятия совместного решения врачом лабораторной диагностики или биологом и врачом-акушером-гинекологом в зависимости от клинической ситуации.

Программа выполняется с использованием инвертированного микроскопа, оснащенного микроманипуляторами.

17. Этапы проведения ИКСИ:

обездвиживание сперматозоидов путем нарушения целостности мембраны хвоста;

нарушение целостности наружной цитоплазматической мембраны ооцита;

введение сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки с помощью микроиглы.

18. Для ИКСИ используются сперматозоиды, полученные из эякулята, хирургическим путем из яичка, придатка яичка.

19. Хирургическое получение сперматозоидов показано при:

азооспермии;

эякуляторной дисфункции, в том числе ретроградной эякуляции, выраженной олигоастенотератозооспермии.

20. Медицинскими противопоказаниями для хирургического получения сперматозоидов являются острые инфекционные заболевания любой локализации.

21. Перед проведением микроинъекции сперматозоида в яйцеклетку осуществляется удаление клеток лучистого венца. Микроманипуляция производится только на зрелых яйцеклетках при наличии первого полярного тельца.

Методика обработки эякулята или аспирата, полученного из яичка или его придатка, определяется врачом клинической лабораторной диагностики или биологом индивидуально для каждого пациента в зависимости от количества и качества сперматозоидов.

22. ЭКО с ИКСИ осуществляется в соответствии с порядком проведения программ ЭКО согласно пунктам 8–15 настоящего клинического протокола.

ГЛАВА 4

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОНОРСКИХ ЯЙЦЕКЛЕТОК

23. ЭКО с использованием донорских яйцеклеток проводится при наличии медицинских показаний в соответствии с постановлением № 170 и с порядком проведения программ ЭКО и ЭКО с ИКСИ согласно пунктам 8–22 настоящего клинического протокола.

24. Недостаточным ответом яичников на стимуляцию суперовуляции считается получение 3 и менее яйцеклеток в предыдущих стимуляциях в программах ЭКО.

25. Критерием, указывающим на снижение овариального резерва, который с высокой вероятностью не позволит получить собственные яйцеклетки, является уровень

антимюллерова гормона в сыворотке крови менее 0,5 нг/мл и (или) менее 5 антральных фолликулов в обоих яичниках, когда показана донация яйцеклеток.

26. К эмбрионам низкого качества относятся эмбрионы качества Grade 3 и 4 на третьи сутки, либо любые эмбрионы, не достигшие стадии бластоцисты на 5 и(или) 6 сутки, либо бластоцисты ВС, СВ, СС по международной классификации Гарднера.

27. Яйцеклетки, полученные от анонимного донора, используются только после их криоконсервации и прохождения карантинного периода, длительность которого составляет 6 месяцев.

Яйцеклетки, полученные от неанонимного донора, могут быть использованы без их криоконсервации и прохождения карантинного периода.

28. ЭКО с использованием донорских яйцеклеток включает следующие этапы:

28.1. подготовка эндометрия женщины преимущественно ЛП группы эстрогенов (в таблетированной и (или) трансдермальной форме) и прогестерона;

28.2. получение свежих яйцеклеток у неанонимного донора или размораживание криоконсервированных яйцеклеток у анонимного или неанонимного донора и оплодотворение специально подготовленными сперматозоидами супруга, как при проведении ЭКО с применением ИКСИ;

28.3. культивирование эмбрионов от 48 до 168 часов;

28.4. перенос эмбрионов в полость матки женщины.

29. Программа ЭКО с использованием донорских яйцеклеток может быть дополнена следующими этапами:

криоконсервацией эмбрионов;

переносом в матку размороженных после криоконсервации эмбрионов (криопротокол);

ПГТ эмбрионов.

30. Поддержка лютеиновой фазы после переноса эмбрионов проводится преимущественно ЛП группы эстрогенов (в таблетированной и (или) трансдермальной форме) и прогестерона. Режим дозирования определяется лечащим врачом-акушером-гинекологом для каждого пациента индивидуально.

31. Диагностика беременности проводится в соответствии с пунктом 14 настоящего клинического протокола.

ГЛАВА 5

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ СПЕРМАТОЗОИДАМИ СУПРУГА ИЛИ ДОНОРА

32. Искусственная инсеминация (далее – ИИ) для лечения бесплодия применяется при наличии медицинских показаний с учетом отсутствия медицинских противопоказаний к применению ВРТ и к донорству половых клеток в соответствии с постановлением № 170.

33. ИИ проводится в естественном цикле или с использованием КОС под ультразвуковым мониторингом.

34. Проведение ИИ включает следующие этапы:

34.1. мониторинг овуляции (ультразвуковой и (или) гормональный);

34.2. КОС (при отсутствии медицинских противопоказаний);

34.3. специальная подготовка сперматозоидов супруга (донора) (метод специальной обработки спермы, направленной на выделение фракции подвижных морфологически нормальных сперматозоидов, зависит от ее параметров и определяется врачом клинической лабораторной диагностики или биологом);

34.4. введение подготовленных сперматозоидов в полость матки в объеме не более 1,0 мл суспензии отмытых сперматозоидов проводится через 24–40 часов после введения триггера овуляции или при выявлении признаков спонтанной овуляции.

35. Поддержка лютеиновой фазы назначается врачом-акушером-гинекологом.

36. Диагностика беременности проводится в соответствии с пунктом 14 настоящего клинического протокола.

ГЛАВА 6

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

37. Для лечения бесплодия суррогатное материнство применяется при наличии медицинских показаний с учетом отсутствия медицинских противопоказаний к применению ВРТ и медицинских противопоказаний для суррогатного материнства (суррогатная мать) в соответствии с постановлением № 170.

38. В программе суррогатного материнства обязательным условием является наличие генетической связи будущего ребенка хотя бы с одним из предполагаемых родителей.

Одновременное использование донорских яйцеклеток и донорских сперматозоидов в программах суррогатного материнства не допускается.

39. Программа суррогатного материнства включает в себя следующие этапы:

39.1. получение и оплодотворение яйцеклеток генетической матери специально подготовленными сперматозоидами супруга (донора) в соответствии с подпунктами 8.1–8.5 пункта 8 настоящего клинического протокола. При наличии медицинских показаний к проведению ЭКО с донорской яйцеклеткой возможно оплодотворение яйцеклеток донора сперматозоидами супруга в соответствии с подпунктом 28.2 пункта 28 настоящего клинического протокола;

39.2. культивирование эмбрионов от 48 до 168 часов;

39.3. подготовка эндометрия суррогатной матери преимущественно ЛП группы эстрогенов (в таблетированной и (или) трансдермальной форме) и прогестерона;

39.4. перенос не более двух эмбрионов в полость матки суррогатной матери.

40. Диагностика беременности проводится в соответствии с пунктом 14 настоящего клинического протокола.

41. Программа ЭКО с суррогатным материнством может быть дополнена следующими этапами:

криоконсервацией эмбрионов;

переносом в матку размороженных после криоконсервации эмбрионов;

ПГТ эмбрионов.